

【소속, 성명】 : □부, 대리 AC

【제 목】 : 7개질병군 포괄수가 전면개편 정책지원

【내 용】

□ 추진배경

- 그간 포괄수가는 '12.7월 7개 질병군 포괄수가 당연지정(확대) 이후 매년 환산지수 등 일부 수가 변동만을 반영하였으나, 최근 의료환경 변화를 반영하고 포괄수가의 지불정확성을 높이기 위해 수가개편의 필요성이 대두됨

* '19년 제1차 국민건강보험종합계획 2-2-4 포괄·묶음 방식의 수가제도 확대

□ 추진내용

- 수가개편을 위해 요양기관 진료내역 및 비용자료 등 기초자료를 수집하고, 자료정제 및 급여기준에 따라 자료를 분석하여 수가산출 자료를 구축하여 포괄수가 개발
 - 진료내역 요양기관 122개소, 비용자료 공공병원 39개소 등 자료수집
- 최근의 진료행태를 파악하여 환자 재원일수, 평균입원일수를 개정, 포괄수가를 구성하고 있는 행위, 약제·치료재료의 구성비율 개정
 - 평균입원일수 0.1~2.7일 감소, 정상군 상한일수 2~8일 감소
- 공공병원의 비용자료를 분석 후 행위유형별 비용변환지수(CCR)를 활용하여 비용기반의 수가를 처음 도입·개편
 - CCR(Cost to Charge Ratio): Cost는 비용, Charge는 행위별진료비
- 또한, 관련 4개 진료과목 의학회, 의사회 등 의견을 수렴을 통해 절삭기, 수술후 유착방지제 등 고가의 선택진료항목에 대하여 별도보상을 신설하는 등 의료의 질 제고와 환자 선택권을 높이기 위해 노력함

- 아울러, 그간의 건의사항 등을 검토·반영하고 수정체수술에서 비급여 인공수정체를 사용한 경우 중복보상을 방지하기 위해 인공수정체 금액을 제외하고 청구토록 개선하여 제도의 유연성을 높임
 - 수정체수술(단안) 비급여 렌즈 사용 시 연성렌즈 비용 129,300원 제외
- 수가개편 이후 청구형태 변화 등을 분기별 모니터링

□ 추진성과

- (최초 비용기반 수가도입) '13.7월 포괄수가 전종별 확대이후 7년 만에 최신 의료행태를 반영한 비용기반 수가를 처음으로 도입·개편함
 - 전체 행위를 16개로 구분하여, 행위별진료비와 이에 대응하는 비용을 분석한 공공병원 자료를 이용해서 ADRG별, 행위유형별 CCR 추정·반영
 - 기존 수가 대비 평균 6.5% 인상되어, 질병군별로 편도(21.3%), 탈장(14.1%), 수정체(10.1%), 자궁(9.5%), 충수(2.7%), 제왕절개(1.5%), 항문(기존과 같음) 수술 순으로 개선
 - '20년 1월 수가는 행위 환산지수 및 약제·치료재료 상한가 변화율을 반영하여 1.9% 추가 인상(평균 8.5% 인상)

(단위: 천원)

질병군	' 19.1월 수가	' 20.1월 수가*	질병군	' 19.1월 수가	' 20.1월 수가*
수정체	936	1,051	항문	920	940
편도	1,092	1,346	자궁·부속기	2,689	2,991
충수	2,621	2,731	제왕절개분만	1,887	1,951
탈장	1,613	1,871			

* 개편 수가에 '20년 환산지수 및 약제·치료재료 상한가 변화 반영

- (수가모형 개선) 의료의 질 제고와 환자 선택권을 높이기 위해 선택진료항목 8항목에 대해 별도보상하여 제도의 유연성을 높임
 - 실포괄수가와 동일하게 급여항목은 80%를 보상하고, 나머지 20%는 포괄수가에 반영, 선별급여 항목은 100% 별도보상

별도보상 항목	급여구분 (보상률)
- 수정체낭고정용 - 절삭기(초음파/전파) - 메쉬류(COMPOSITE, 일반, 골반장기탈출증 이식용, 기타 MESH)	급여(0.8)
1회용 절삭기(초음파/전파/다관절 다자유도 바이폴라) - 수술후 유착방지용(FILM/GEL/SOLUTION TYPE) - 동맥압에 기초한 심기능 측정용 - 열희석법 보정 후 동맥압에 기초한 심기능 측정용	선별급여
코블레이터(편도·아데노이드 절제술용/고주파 설근부 축소술용/고주파를 이용한 하비갑개 용적감소술용 재료)	비급여

* 중분류 60 항목, 치료재료품목 코드 274품목('20. 1. 1. 기준)

○ (진료비 계산식 개선) 포괄수가 진료비 계산식을 국민들이 이해하기 쉬운 계산식으로 개선

- 현 고정비율 대신 질병군별 기준점수·일당점수를 이용하여 입원기간에 따른 진료비 산정기준을 실포괄수가 모형과 동일하게 변경

현재 계산식	개정 계산식
$\begin{aligned} & \text{【질병군별 상대가치점수} \times \text{고정비율} + \{\text{질병군별} \\ & \text{상대가치점수} \times (1 - \text{고정비율}) \times \text{입원일수} \\ & \div \text{질병군별 평균 입원일수}\}] \times 20/100 \\ & + \\ & \text{【질병군별 점수】} \times 80/100 \end{aligned}$	$\begin{aligned} & \text{【질병군별 기준상대가치점수} + \{(\text{입원일수} \\ & - \text{질병군별 평균 입원일수}) \times \text{질병군별} \\ & \text{일당상대가치점수}\}] \times 20/100 \\ & + \\ & \text{【질병군별 기준상대가치점수】} \times 80/100 \end{aligned}$
* 고정비율: 요양급여비용 총액 중 입원일수와는 관계없이 평균적으로 발생하는 비용의 비율 * 기준 상대가치점수: 질병군별 평균 입원일수만큼 입원했을 때 발생하는 입원 건당 상대가치점수 * 일당 상대가치점수: 입원일수가 1일 증가함에 따라 추가되는 질병군별 상대가치점수	

□ 향후 추진계획

○ 비용기반 포괄수가의 정례적 조정기전(3년 주기 대조정 및 연차별 소조정)을 마련하여 의료 공급자 수용성 증대 및 포괄수가의 지불정확성 제고